

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5012020-89.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: GILBERTO PIRES DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE MARCAÇÃO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar. Intimem-se. Sem honorários, considerando a natureza da causa. Com o trânsito em julgado, arquite-se o processo, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5012020-89.2025.4.02.5101

510015714045 .V6

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5012020-89.2025.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: GILBERTO PIRES DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência, com pedido de liminar, na qual **GILBERTO PIRES DA SILVA** objetiva atribuir efeito suspensivo ativo à decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela definitiva, por meio da qual a parte pleiteia a marcação de "CIRURGIA ORTOPÉDICA DE JOELHO", sob a alegação de urgência quanto ao referido atendimento, aliado ao diagnóstico de doença grave.

A liminar foi indeferida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório.

VOTO

De plano, no caso em tela não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão (Evento 3), a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de medida de urgência interposta pela parte autora em face da decisão, verbis: (evento 8, DOC1)

"De início, defiro a gratuidade de justiça, consoante requerido na inicial.

***Gilberto Pires da Silva**, devidamente qualificado nos autos, juíza a presente ação, com pedido de antecipação de tutela, em face da **União Federal, Estado do Rio de Janeiro e Município do Rio de Janeiro**, objetivando que os réus sejam condenadas a providenciarem,*

de forma imediata, CONSULTA EM ORTOPEDIA e posterior CIRURGIA ORTOPÉDICA, nos termos da inicial.

DECIDO.

Analisando o acervo documental, depreende-se que a autora tem indicação para realização do referido tratamento, conforme documentos médicos acostados aos autos (Evento 1 Anexo 2 Fls. 09/12 e Parecer do NAT de Evento 6).

Em que pesem tais circunstâncias, de todo inegáveis, fato é que a parte autora está inscrita no SER, já realizou Consulta em Ortopedia e conforme informações fornecidas pelo NAT em seu parecer o "paciente passou pela consulta de cirurgia do joelho LCA/artroscopia, avaliação médica constatou que o paciente é caso cirúrgico, porém não possui perfil para nossa unidade devido IMC revisão cirúrgica - solicitamos que encaminhe para outra unidade que absorva o caso do paciente e também perca peso para uma cirurgia no futuro". Assim, permanece com estado atual: Em fila, posição: 496º".

Destarte, em havendo outros pacientes em igual ou mais crítica situação clínica do que a do autor, nesta mesma fila de espera e em posição anterior àquela que o mesmo ocupa, não se afigura isonômico que, em virtude de ordem judicial, o autor seja submetido de pronto à cirurgia de que necessita, a despeito dos outros pacientes, que, tanto quanto ele, são titulares do direito constitucional da assistência à saúde, fornecida pelo Estado.

Sobre o tema, o TRF2, já teve oportunidade de se manifestar, conforme se infere da ementa abaixo transcrita:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA. INTO. RESPEITO À **FILA** ADMINISTRATIVAMENTE ORGANIZADA. 1. O direito à saúde implica para o Poder Público o dever inescusável de adotar providências necessárias e indispensáveis para a sua promoção, estabelecidas de forma universal e igualitária. Nesse contexto jurídico, se o Poder Público negligencia no atendimento de seu dever, cumpre ao Poder Judiciário intervir, num verdadeiro controle judicial de política pública, para conferir efetividade ao correspondente preceito constitucional. 2. Todavia, o acesso ao referido direito deve ser compatibilizado com o princípio da isonomia, de forma a não garantir privilégios àqueles que procuram o Judiciário em detrimento dos que aguardam por tratamentos e cirurgias de acordo com a **fila** administrativamente estabelecida. Assim, não cabe ao Judiciário administrar hospitais, estabelecendo prioridades de natureza médica. Precedentes. 3. Dessa forma, cabe à Administração Pública, mediante exame com base em critérios técnicos, aferir a possibilidade de internação no INTO ou em qualquer outro hospital da rede pública, respeitando a **fila** administrativamente estabelecida. 4. É inviável, em um quadro insatisfatório, socializar o custeio de internação em rede hospitalar privada. Do mais, o deferimento do pedido, nesta hipótese, também representaria verdadeira preterição aos pacientes que aguardam na **fila** de **espera**. Precedentes. 5. Apelação conhecida e desprovida.

(TRF2, Sétima Turma, AP 0113602-43.2013.4.02.5101, Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTONIO NEIVA, Dje 27/10/2016)

Isto posto, **INDEFIRO** a tutela de urgência pleiteada.

Citem-se os réus"

É o breve relatório.

Sabe-se que são requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência: a) a probabilidade do direito pleiteado, ou seja, uma plausibilidade lógica que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, do que decorre um provável reconhecimento do direito, baseada em uma cognição sumária; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso não concedida, ou seja, quando houver uma situação de urgência em que se não se justifique aguardar o desenvolvimento natural do processo sob pena de ineficácia ou inutilidade do provimento final.

A parte autora não comprovou os requisitos.

A parte autora comprovou apresentar quadro clínico de gonartrose à esquerda, com soltura de artroplastia total de joelho (ATJ) primária (Evento 1, ANEXO2, Página 9).

O NAT juntou parecer no evento 6, PARECER1.

Rio de Janeiro, 03 de fevereiro de 2025.

Processo nº 5006847-84.2025.4.02.5101,
ajuizado por **Gilberto Pires da Silva**.

Trata-se de Autor com quadro clínico de **gonartrose** à esquerda, apresentando soltura de artroplastia total de joelho (ATJ) primária (Evento 1, ANEXO2, Página 9), solicitando o fornecimento de **consulta em ortopedia e cirurgia ortopédica** (cirurgia de revisão do joelho) (Evento 1, INIC1, Página 9).

De acordo com a Portaria n. 503, de 08 de março de 2017, que aprova normas de autorização de **prótese total de joelho** e de prótese total de quadril híbrida¹, O procedimento de artroplastia total do joelho é a melhor opção de tratamento para os casos de artrose avançada, pois propicia a melhora da função, diminuição da dor e consequente melhoria da qualidade de vida do paciente. Este procedimento está indicado em pacientes com faixa etária entre 55 e 85 anos de idade, com artrose avançada, que apresentem condições clínicas satisfatórias para suportar o procedimento cirúrgico. Dentre as indicações, constam a **gonartrose** e complicação mecânica de dispositivo de fixação, o que configura o caso do Autor.

Diante do exposto, informa-se que a **consulta em ortopedia e cirurgia ortopédica** (cirurgia do joelho) **estão indicadas** ao manejo do quadro clínico do Autor - **gonartrose à esquerda**, apresentando soltura de componente de artroplastia total de joelho primária (Evento 1, ANEXO2, Página 9). Além disso, **estão cobertas pelo SUS**, conforme Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS (SIGTAP) na qual constam: **consulta médica em atenção especializada, artroplastia total de joelho - revisão / reconstrução**, sob os seguintes códigos de procedimento: 03.01.01.007-2, 04.08.05.005-5, considerando o disposto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES).

Para regulamentar o acesso aos procedimentos em ortopedia incorporados no SUS, o Ministério da Saúde publicou a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que estabelece a **Política Nacional de Atenção de Alta Complexidade em Traumatologia-Ortopedia**, prevendo a organização de forma articulada entre o Ministério da Saúde, as Secretarias de Estado da Saúde e do Distrito Federal e as Secretarias Municipais de Saúde, por intermédio de redes estaduais e regionais, bem como contando com os Componentes da Atenção Básica, Especializada e das Redes de Atenção em Ortopedia Regional de cada unidade federada.

Nesse sentido, no Estado do Rio de Janeiro, foi pactuado na Comissão Intergestores Bipartite as Deliberações CIB-RJ nº 1.258 de 15 de abril de 2011 e CIB-RJ nº 561 de 13 de novembro de 2008 (**ANEXO I**)², que aprovam a **Rede de Traumatologia e Ortopedia de Média e Alta Complexidade no Estado do Rio de Janeiro**. Assim, o Estado do Rio de Janeiro

conta com as unidades habilitadas no SUS para atenção ortopédica e suas referências para as ações em ortopedia de média e alta complexidade no Estado do Rio de Janeiro.

O ingresso dos usuários nas unidades que ofertam os serviços do SUS, ocorre por meio do sistema de regulação, conforme previsto na Política Nacional de Regulação que organiza o serviço em três dimensões (Regulação de Sistemas de Saúde, Regulação da Atenção à Saúde e Regulação do Acesso à Assistência) para qualificar a atenção e o acesso da população às ações e aos serviços de saúde³.

Em consulta à plataforma do Sistema Estadual de Regulação – SER (ANEXO II) foi localizado para o Autor, solicitação de **Consulta - Ambulatório 1ª vez em Ortopedia - Joelho (Adulto)**, realizada em 12/08/2024, pelo Hospital Universitário Pedro Ernesto - HUPE, com a seguinte observação: *“Paciente passou pela consulta de cirurgia do joelho LCA/artroscopia, avaliação médica constatou que o paciente é caso cirúrgico, porém não possui perfil para nossa unidade devido IMC revisão cirúrgica - solicitamos que encaminhe para outra unidade que absorva o caso do paciente e também perca de peso para uma cirurgia no futuro”*. Assim, permanece com estado atual: **Em fila**, posição: **496º**.

Desta forma, entende-se que a **via administrativa para o caso em tela já está sendo utilizada**. Contudo, ainda sem a resolução da referida demanda.

É o Parecer

*O parecer esclareceu que : “Em consulta à plataforma do Sistema Estadual de Regulação - SER (ANEXO II) foi localizado para o Autor, solicitação de Consulta - Ambulatório 1ª vez em Ortopedia - Joelho (Adulto), realizada em 12/08/2024, pelo Hospital Universitário Pedro Ernesto - HUPE, com a seguinte observação: “Paciente passou pela consulta de cirurgia do joelho LCA/artroscopia, avaliação médica constatou que o paciente é caso cirúrgico, **porém não possui perfil para nossa unidade devido IMC revisão cirúrgica** - solicitamos que encaminhe para outra unidade que absorva o caso do paciente e também **perca de peso para uma cirurgia no futuro**”. Assim, permanece com estado atual: Em fila, posição: 496º.”*

Observa-se, assim, que o parecer esclareceu que o paciente não está apto para a cirurgia, solicitando a perda de peso para cirurgia no futuro, bem como esclareceu que o paciente aguarda em fila.

A organização da fila de espera é baseada em critérios médico-científicos, de forma que a intervenção do Poder Judiciário só pode se dar em hipóteses excepcionais, em casos de flagrante desrespeito à regulação ou de urgência devidamente comprovada, nos termos do Enunciado 51 da II Jornada de Saúde do CNJ:

*“ENUNCIADO Nº 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, **com expressa menção do quadro clínico de risco imediato**.”*

Assim, em uma cognição sumária, pode-se concluir que está ausente a probabilidade do direito pleiteado. Por essas razões, indefiro o requerimento liminar de atribuição de efeito suspensivo ativo. Intimem-se.”

Logo, não estava, ainda, demonstrada a existência de verossimilhança nas alegações e do risco de lesão grave e/ou de difícil reparação, para que pudesse ser concedido efeito suspensivo ativo.

Por tais razões, **VOTO** por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO** ao recurso e ratifico a decisão que indeferiu a liminar. Intimem-se. Sem honorários, considerando a natureza da causa. Com o trânsito em julgado, archive-se o processo.